جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سالمه سليمان سالم راضي

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اخري **العنوان :** 26ش الغربي بجوار مستودع حلوان القاهره

رقم البطاقة : 25302252100301 **رقم التليفون :** 01110613607 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 25-02-1953 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للرقبة والصدر والبطن والحوض بالصبغة [11128] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سالمه سليمان سالم راضي
National ID: 25302252100301

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

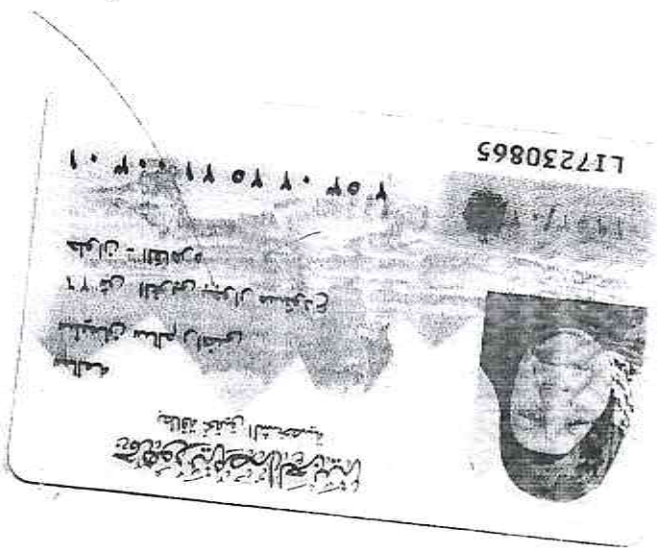
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of neck, chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	سالمه سليمان سالم راضى	**Case No.**	**383779**
Sex/Age	**Female 73 Y**	**Patient No.**	**26648**
Registered Date	**10/9/2026 02:11:13 PM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**22/9/2026 12:26:21 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**30/9/2026 10:42:08 AM**	**Pathology No.**	**2836/26**

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 4c).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 3/09/2026, Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Four greyish, white tissue cores, ranging in length from 0.3 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
-Histologic type: Invasive mucinous carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Negative membrane staining reaction in more than 10% tumor cells (score 0).
- Ki67%: 10%.

Conclusion:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
-Invasive mucinous carcinoma, Grade 2.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي الترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	سالمه سليمان سالم راضى	**Case No.**	**383779**
Sex/Age	**Female 73 Y**	**Patient No.**	**26648**
Registered Date	**10/9/2026 02:11:13 PM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**22/9/2026 12:26:21 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**30/9/2026 10:42:08 AM**	**Pathology No.**	**2836/26**

- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 10%.

****Scoring system: "ER, PR"***
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
***** Scoring system: "Her2"***
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

وزارة الصحة و السكان
مديرية الشئون الصحية بمحافظة
مستشفى حلوان العام

اسم المريض :سالمه سليمان سالم

التاريخ : 2026/8/31

Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With Complementary Breast US Examination Of Both Breasts Revealed:

- ACR A: predominant fatty breast parenchyma.
- A well-defined hyper-dense lesion is seen at the LIQ of the right breast corresponding by US to a well-defined globular shaped heterogeneous hypoechoic lesion is seen at 4-5 o'clock showing internal vascularity. It measures 2.5x2.1 cm.
- Few enlarged right axillary LNs , some of the are seen showing increased cortical thickness (>3mm) and effaced fatty hilum. The largest measures 1x0.6 cm.
- No pathological microcalcification clusters.
- No left breast solid or cystic lesions.
- Normal central ducts system.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Left non-specific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

Right breast LIQ suspicious looking lesion associated with ipsilateral intermediate axillary lymphadenopathy (BIRADS 4C); for histo-pathological correlation.

Dr.Marwa M.Selim,MSc

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :1-9-2026 جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) سالمه سليمان سالم راضى بطاقة رقم 25302252100301

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى معاش بدون خصم حصه التامين الصحى

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :1-9-2026

الموظف المختص

محمود عبدالله

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

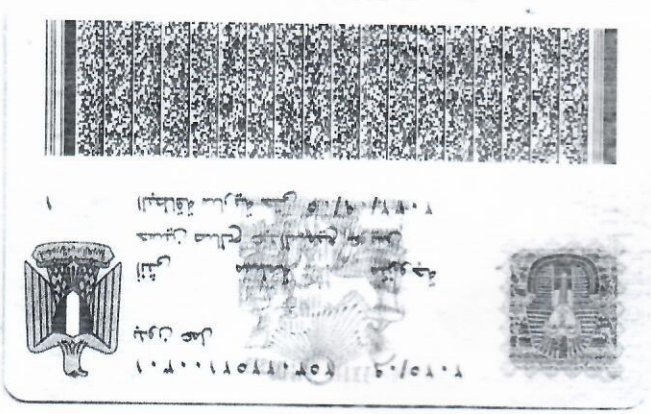
مسلسل 2066296

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :1-9-2026

جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) سالمه سليمان سالم راضى بطاقة رقم 25302252100301

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى معاش بدون خصم حصه التامين الصحى

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا لهيئة التأمين الصحى

تاريخ الطباعه :1-9-2026

الموظف المختص

محمود عبدالله

00848 1

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

مسلسل 2066296

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]

وزارة الصحة والسكان
مديرية الشئون الصحية بالقاهرة
مستشفى حلوان العام

اسم المريض :سالمه سليمان سالم

التاريخ : 2026/8/31

Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With Complementary Breast US Examination Of Both Breasts Revealed:

- ACR A: predominant fatty breast parenchyma.
- A well-defined hyper-dense lesion is seen at the LIQ of the right breast corresponding by US to a well-defined globular shaped heterogeneous hypoechoic lesion is seen at 4-5 o'clock showing internal vascularity. It measures 2.5x2.1 cm.
- Few enlarged right axillary LNs , some of the are seen showing increased cortical thickness (>3mm) and effaced fatty hilum. The largest measures 1x0.6 cm.
- No pathological microcalcification clusters.
- No left breast solid or cystic lesions.
- Normal central ducts system.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Left non-specific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

Right breast LIQ suspicious looking lesion associated with ipsilateral intermediate axillary lymphadenopathy (BIRADS 4C); for histo-pathological correlation.

Dr.Marwa M.Selim,MSc

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]